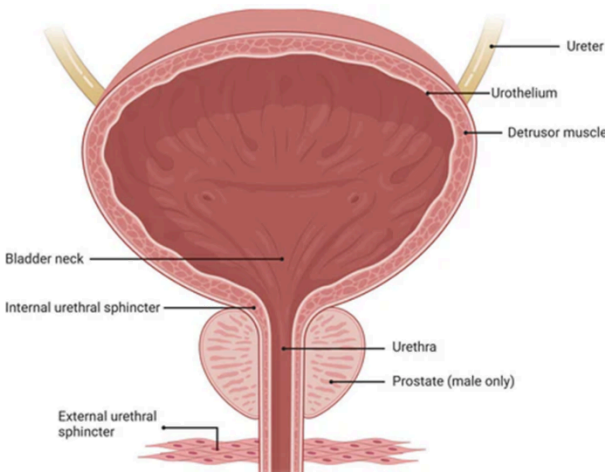
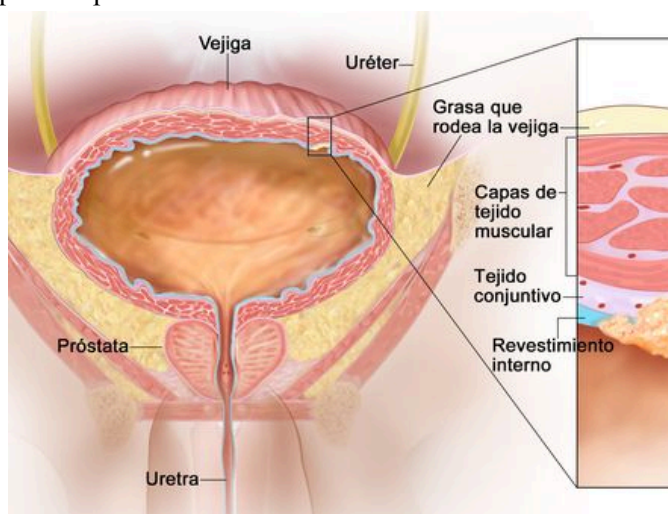




NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>CISTECTOMÍA RADICAL</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) Resección de la vejiga urinaria de forma radical. La condición más común para realizar esta cirugía es el cáncer. 1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA  La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Con una capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 ML. La vejiga posee 3 porciones:			

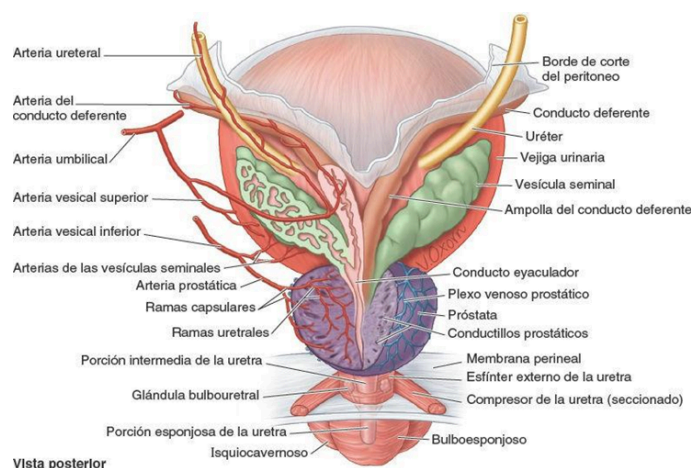
- o **Cuerpo:** Dónde la orina es recolectada.
- o **Fondo (Base):** Contiene al trigono vesical.
- o **Trígono Vesical:** Donde se localiza la uretra.

A su vez se compone por 3 capas:



- **Capa Serosa:** Se compone de tejido conectivo alveolar.
- **Capa Muscular:** Formada por 3 capas de fibras musculares lisas: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
- **Capa Mucosa:** Compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente.

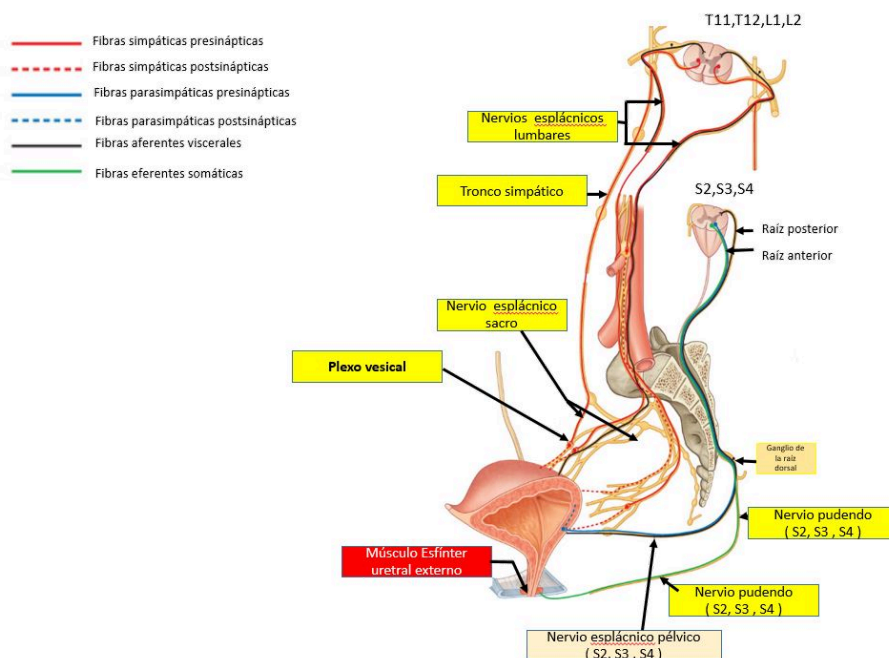
IRRIGACIÓN.



Es drenada por las **venas ilíacas internas**, y tanto en hombres como en mujeres, los vasos linfáticos de las caras supero laterales de la vejiga desembocan en los **ganglios linfáticos ilíacos externos**

INERVACION

Involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático



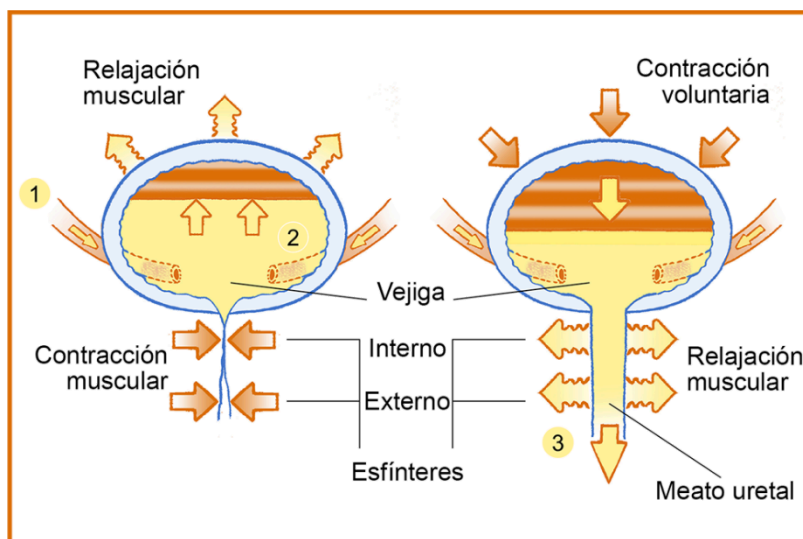
1. Las fibras simpáticas presinápticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal a través de los nervios espláncnicos lumbares pasando por el tronco simpático lumbar, plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos hacia los plexos vesicales (pélvicos). Es un subplexo del plexo hipogástrico inferior, de ahí envían fibras autónomas postsinápticas a las paredes de la vejiga urinaria.
2. Las fibras parasimpáticas presinápticas para la vejiga urinaria se originan en las neuronas de los segmentos sacros de la médula espinal S2-S4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales sacros, a través de los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, hasta la vejiga urinaria.

RELACIONES DE LA VEJIGA:

- **PARTE ANTERIOR:**
- Sínfisis del pubis
- Espacio prevesical de Retzius.
- Músculos de la pared abdominal
- Fascia umbilicoprevesical
- Uraco
- Vasos umbilicales obliterados

- **PARTE INFERIOR:**
- Músculo elevador del ano
- Músculos internos de la pelvis
- **PARTE POSTERIOR:**
- Tiene el fondo de saco vésico rectal de Douglas y la Ampolla rectal.
- **PARTE SUPERIOR:**
- Uréteres, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales.

FISIOLOGIA



Los músculos de la vejiga que permiten el control voluntario de la micción y permiten 2 funciones: 1) la sensación que permite que reconozcas que tu vejiga está llena y debe ser vaciada y 2) el control motor que permite que puedas orinar voluntariamente.

Primero, como la pared vesical se estira cuando está llena o próxima a su máxima capacidad, existen señales que son transmitidas a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor, el cual es una capa de la pared vesical constituida por fibras de músculo liso que son ordenadas en fascículos longitudinales, circulares o en espiral, esta señal estimulará a la vejiga para expulsar orina a través de la uretra, luego, estas sensaciones dentro de la vejiga serán transmitidas al sistema nervioso central (SNC) por medio de fibras aferentes viscerales generales (AVG). Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso de los nervios simpáticos eferentes hasta el SNC, las fibras aferentes en la porción inferior siguen a las fibras parasimpáticas eferentes.

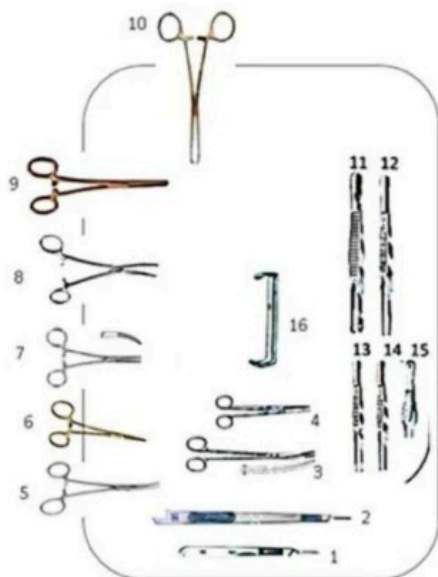
1.3. LISTA DE CHEQUEO:



INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Equipo de general Equipo vascular Clamps Intestinales	Paquete de ropa Sonda Foley 22 x 30 Jeringa de 20 cc Gasas Caucho de succión Asepto jeringa Torundas Hoja de bisturí 15- 20 Lapicero de electro bisturí Guantes Cistofló Equipo de venoclisis Sonda nelaton Ligasure Frascos de patología	PIEL: Polipropileno 3/0 aguja curva cortante 3/8 de circulo TCS: Catgut cromado 3/0 aguja redonda medio círculo. FASCIA: Poliglactin 0 o 1 aguja curva redonda de ½ de círculo Seda 2/0 o 3/0 precortadas Poliglactina 910 3/0 para anastomosis	Solución salina

• **ETAPA DE ORGANIZACIÓN:**

- o **ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).**



1. Mango de bisturí 4 hoja 20
2. Mango de bisturí 3 hoja 15
3. Tijera de Metzembbaum
4. Tijera de mayo recta
5. Pinza Kelly curva
6. Pinza Kelly recta
7. Pinza Kelly Adson
8. Pinza Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinza Allis
11. Pinza disección rusa
12. Pinza disección sin garra larga
13. Pinza disección con garra corta
14. Pinza disección sin garra corta
15. Pinza disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

1. Equipo general
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Coca con suero
6. Cánula de yankawer
7. Porta aguja
8. Sutura
9. Tijera de Metzenbaum fina
10. Tijera de mayo larga
11. Pinza de Foerster
12. Pinza de campo Backhouse
13. Compresas
14. Lápiz de electrobisturí
15. Paquete de ropa
16. Guantes
17. Caucho de succión
18. Frascos de patología





2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Posición de Litotomía + Trendelenburg

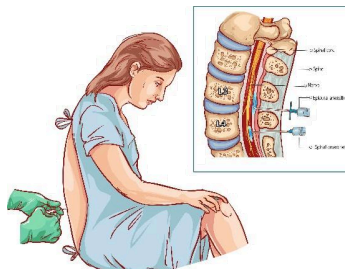


2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):



• ETAPA DE EJECUCION:

- ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA): Anestesia general o raquídea



- INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):



Abordaje abdominal abdominopélvico abierto : Incisión mediana infraumbilical

- **PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión en línea media infraumbilical	mango de bisturí 3 hoja de bisturí 15
Se incide la fascia muscular del recto verticalmente	Tijera de Mayo
Se rechazan a los rectos lateralmente por su línea media. Incisión de la vaina posterior de los rectos hasta acceder al peritoneo y grasa preperitoneal.	Separadores Bisturí
Se realiza una cuidadosa y sistemática inspección de la cavidad abdominal, para evaluar la presencia de metástasis hepáticas o adenopatías retroperitoneales.	
Se moviliza el ciego y colon derecho medialmente, realizando una incisión de la línea blanca de Toldt y peritoneo posterior que permita liberar al intestino de sus adherencias retroperitoneales cranealmente, hacia el ligamento de Treitz.	Mango de bisturí 4 Tijeras de Metzembaum
Se desplazan hacia el epigastrio el paquete de asas intestinales y el colon derecho, cubriéndolos con paños verdes humedecidos que ayudan a contenerlas cranealmente	separador de Bookwalter
Se diseccionan ambos uréteres. Su disección se prolonga cuidadosamente hacia la pelvis hasta su entrada en vejiga.	



Se realiza la linfadenectomía	
Se disea el pedículo vascular lateral vesical, de localización distal a la arteria hipogástrica.	ác. poliglicólico (DEXON®) del 0 o del 2 o con sellado vascular LIGASURE® STD.
La arteria hipogástrica puede ser ligada distal a la salida de la arteria glútea, sin seccionarse.	LIGASURE
El peritoneo posterior se incide lateralmente en ambos lados desde los vasos iliacos hacia el canal femoral como límite lateral de resección que se extirpará con la pieza.	Tijeras de Metzembraum Mango de bisturí 4 Electrobisturí
Disección apical: En los hombres, generalmente consiste en extirpar la próstata y las vesículas seminales.	
Cistectomía radical en la mujer: En las mujeres, la cistectomía radical implica extirpar el útero, los ovarios y parte de la vagina.	
FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA IQX-FT-024-UDES	



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01